

SCLEROTERAPIA – DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE

Io sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il ____/____/____,
residente a _____,
Via _____, n. _____,
oggi: data ____/____/____ ora ____:____,

in qualità di:

☐ Me stesso ☐ Genitore ☐ Tutore / Amministratore di sostegno

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia responsabilità,

DICHIARO

- di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto sanitario proposto, attraverso la scheda informativa allegata e il colloquio con l'operatore sanitario;
- di essere consapevole che è mio diritto richiedere ulteriori spiegazioni in ogni momento;
- di essere consapevole che posso revocare le decisioni qui espresse sino al momento dell'esecuzione della prestazione.

Avendo compreso quanto spiegato, decido liberamente e consapevolmente di:

☐ Acconsento ☐ NON Acconsento

ad essere sottoposto/a al trattamento di scleroterapia, tenuto conto anche delle conseguenze derivanti dall'esecuzione della prestazione proposta, così come descritte nella scheda informativa allegata.

Data del colloquio: ____/____/____

Firma del paziente (o di chi ne fa le veci*) _____

(*) Per il paziente minorenne il consenso informato deve essere firmato da entrambi i genitori.

Consenso ottenuto con l'ausilio di un interprete: SI ☐ NO ☐

Firma dell'interprete: _____

Firma del Professionista Sanitario presente: _____

SCHEDA INFORMATIVA – LA SCLEROTERAPIA

Cosa sono le varici?

Le varici sono determinate da una dilatazione di vene superficiali all'interno delle quali il sangue refluisce verso il piede anziché risalire al cuore. È necessario fermare questo reflusso di sangue se si desidera evitare possibili conseguenze quali:

- alterazione della cute e delle parti sottostanti (ulcera, infiammazioni);
- tromboflebite superficiale (la vena si riempie di sangue coagulato);
- comparsa di trombosi profonda (sangue coagulato in una vena profonda);
- progressivo aggravamento delle varici esistenti;
- progressivo aggravamento delle microvaricosità esistenti ("capillari dilatati").

Come funziona la scleroterapia?

La scleroterapia consiste nell'iniezione di una sostanza sclerosante all'interno della vena varicosa. Il prodotto sclerosante va introdotto in uno o più punti: durante una seduta scleroterapica verranno pertanto effettuate una o più iniezioni. La scleroterapia determina una irritazione della parete della vena trattata, così da ottenerne la chiusura. Il sangue quindi non passerà più nelle vene ammalate ma defluirà verso il cuore attraverso le vene superficiali sane e le vene profonde, quelle realmente deputate al ritorno del sangue. Il sistema venoso superficiale, infatti, non ha rilevanza nel trasporto del sangue: si tratta di un sistema cosiddetto "accessorio", che diventa rilevante solo quando malato, in quanto fonte di complicanze. Dopo la seduta scleroterapica quasi sempre si forma una infiammazione leggera e transitoria nelle aree dove sono state effettuate le iniezioni; nel punto di iniezione è frequente una ecchimosi (livido).

Quali sono le possibili complicanze?

Complicanze maggiori

Sono rappresentate da:

- reazione allergica, che si manifesta con eruzioni cutanee (arrossamenti, orticaria) o, più raramente, con sintomi respiratori, collasso o morte per shock anafilattico, imprevedibile seppure molto raro: è importante segnalare eventuali allergie a farmaci o a qualsiasi altra sostanza, e anche casi di allergia nella propria famiglia;
- trombosi venosa profonda: non dimenticare di segnalare pregresse "flebiti" e l'eventuale uso di farmaci ormonali (pillola, cerotto, ecc.);
- necrosi ("crosta") cutanea dolorosa e a lenta cicatrizzazione, con esito cicatriziale iperpigmentato e antiestetico;
- iniezione intra-arteriosa: complicanza resa eccezionale dall'ecoscleroterapia, pratica usata correntemente, che consiste nell'iniettare il prodotto sotto guida ecografica nelle vene non visibili (l'origine della vena malata è infatti più lontana e più profonda rispetto alle dilatazioni visibili);
- transitori annebbiamenti della vista, che possono verificarsi utilizzando particolari miscele di farmaco e aria (schiuma).

Le complicanze più gravi intervengono immediatamente, ad esempio quasi tutte le manifestazioni allergiche e il dolore legato a una iniezione intra-arteriosa. Le altre possono sopraggiungere più ore o giorni dopo l'iniezione: in tal caso occorre contattare il proprio medico di fiducia.

Complicanze minori

Dopo la seduta scleroterapica quasi sempre si forma una infiammazione leggera e transitoria nelle aree dove sono state effettuate le iniezioni. Nel punto di iniezione è frequente una ecchimosi (livido), dal momento che la parete della vena ammalata è di cattiva qualità e si rompe facilmente. Se la reazione infiammatoria dovesse essere più rilevante, si potrà apprezzare nella sede di iniezione una pallina o un cordone di consistenza dura: questo non deve preoccupare, in quanto alla visita successiva, se necessario, potrà essere evacuata o aspirata. Queste manifestazioni frequentemente

TD-SGI-MOD084_00 · Rev. 00 · Consenso Informato Scleroterapia

scompaiono senza necessità di intervento medico; talora, tuttavia, possono permanere esiti, soprattutto in forma di colorazione scura o di piccola tumefazione.

Possibili complicanze post-procedurali tardive

La comparsa di iperpigmentazione (macchia di colore scuro lungo il decorso delle vene trattate) è un evento possibile anche in mani molto esperte e anche quando la scleroterapia sia stata eseguita in modo corretto. Essa dipende da fattori individuali (predisposizione), età delle venule dilatate, esposizioni solari o a raggi ultravioletti, reflussi venosi strumentalmente non identificabili e altre cause non note. La pigmentazione si attenua in genere nei mesi successivi e può arrivare a scomparire a seguito di terapie specifiche. La comparsa di piccole venule rosse nelle aree trattate o nelle aree vicine (matting) rappresenta solitamente un fenomeno temporaneo e comunque risolvibile con ulteriori trattamenti; interessa persone predisposte o può dipendere da fattori ormonali o da elementi tecnici non ben chiariti.

Quali sono le possibili alternative al trattamento proposto?

Il trattamento delle varici si avvale di molteplici metodiche, a seconda del tipo clinico di varici, dell'età del paziente e del suo stato clinico generale. Le procedure più frequentemente adottate sono:

- varicectomie isolate, cioè la semplice incisione cutanea e l'asportazione delle varici;
- safenectomia (stripping), che consiste nell'eliminazione della vena grande e/o piccola safena; intervento di solito associato alle varicectomie;
- crossectomia, cioè la legatura e sezione della safena allo sbocco di questa nel sistema venoso profondo;
- C.H.I.V.A., metodica di deconnessione della safena atta a impedire il ristagno di sangue nel sistema venoso superficiale;
- S.E.P.S., metodica mininvasiva di tipo endoscopico per la legatura e interruzione di vene perforanti malate;
- obliterazione endovenosa con metodica laser;
- obliterazione endovenosa con radiofrequenza.

Ulteriori informazioni

Dopo l'iniezione saranno applicati, per un tempo prescritto, una compressione, una calza elastica oppure un bendaggio. La colla dei cerotti può determinare allergia con conseguente dermatite, in genere transitoria; ove si manifesti, occorre tuttavia contattare il curante. Occorre evitare un'attività fisica esagerata il giorno del trattamento e nei giorni successivi, mantenendo comunque le normali attività. Si ricorda, infine, che il trattamento delle vene varicose, anche se piccole, richiede pazienza ed essendo la malattia evolutiva è possibile la comparsa nel tempo di nuove vene dilatate.

Firma del paziente (o di chi ne fa le veci) per presa visione
